Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Personne introuvable (fugue, disparition)

Résident ou enfant absent sans explication (EHPAD, unité protégée, MAS, FAM, IME) : chercher tout de suite, avec méthode, et alerter tôt.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · personne retrouvée qui ne répond pas, respire mal, est blessée, très froide ou très chaude, ou confuse.

1 · Je donne l'alerte

- **Noter l'heure** de découverte et l'**heure de dernière vue** certaine (par qui, où).
- Alerter les collègues présents et le **cadre / l'astreinte de direction**.
- Un professionnel **reste avec le groupe** : les autres personnes restent en sécurité.

2 · Je rassemble les informations

- **Tenue** : vêtements, chaussures, manteau, sac ; aide à la marche, fauteuil ?
- **Vulnérable ?** troubles cognitifs, handicap, enfant, diabète, épilepsie, traitement vital, propos suicidaires.
- Où va-t-elle d'habitude ? ancien domicile, famille, commerce, arrêt de bus.
- Nuit, froid, chaleur ; route, point d'eau ou voie ferrée à proximité ?

3 · J'agis

- **Recherche organisée immédiate** : chambres, toilettes, placards, réserves, jardin, parking, abords ; une zone par personne.
- Préparer la **fiche signalétique** : photo récente, description, tenue, traitements.
- Famille ou **tuteur** prévenus par le cadre ou la direction.
- Retrouvée : rassurer, sans reproche ; paramètres, glycémie capillaire (AS/AP) si diabète ; prévenir l'IDE.
- La **direction** signale la « disparition » à l'autorité dès que la police est alertée.

Je ne fais pas

- Attendre « qu'elle revienne » avant d'alerter.
- Chercher seul sans prévenir, ou laisser le groupe sans surveillance.
- Réprimander ou retenir de force la personne retrouvée.
- Oublier de prévenir police et famille du retour.

J'alerte

Forces de l'ordre (17 ou 112) rapidement si :

- Personne **vulnérable** non retrouvée à l'issue de la recherche immédiate.
- **Sans attendre** : traitement vital, propos suicidaires, nuit, froid ou forte chaleur.
- Personne vue en danger (route, eau, voie ferrée).

J'alerte aussitôt le cadre (astreinte) et l'IDE si :

- **Toute absence inexpliquée**, de jour comme de nuit.
- Retour : l'IDE examine (chute, froid, déshydratation, traitements manqués).
- Médicament critique non pris pendant l'absence.

Je surveille et je trace

- Tracer : heures (dernière vue, découverte, alertes, retour), zones fouillées, personnes prévenues.
- Après le retour : blessures, pieds, hydratation, température ; comportement les jours suivants.
- Analyse en équipe : cause (angoisse, douleur, ennui, projet), prévention d'une nouvelle sortie.

Mention de sécurité

Une absence inexpliquée est une urgence : on cherche tout de suite, avec méthode, et on alerte tôt. Organisation et signalement : fiche socle « Fugue et disparition ».

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 28/12/2016 (dysfonctionnements graves en ESMS), art. 1, 9° ; CASF L331-8-1 ; fiche socle DOTR « Qui signale quoi, à qui ? » (10/2026) ; fiche socle DOTR « Fugue et disparition ». Aucune fiche nationale de conduite à tenir trouvée : contenu proposition DOTR.

Réf. DOTR-AS-FUGUE | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature